Cabinet de dermatologie Es-Senia

تقرير المساعدة على الفرز — آفة جلدية

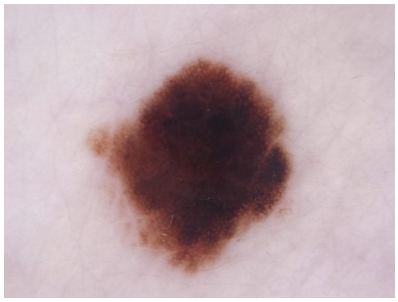
dermIA الإصدار 2.0.0 · النموذج ham10000-bcn20000-m5-v3 الإصدار 3.0.0 (الملف: كامل)

المريض	P-2026-0421	تاريخ التحليل	11:24 18/04/2026
العمر (بالسنوات)	70	طلب التحليل	Dr Karim Haddad
الجنس	أنثى	الموضع	الطرف السفلي
الآفة المتابعة	رقم 1 — jambe gauche	عتبات القرار	الأصلية

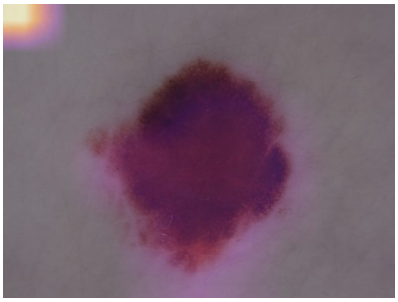
عاجل

اشتباه في ورم ميلانيني

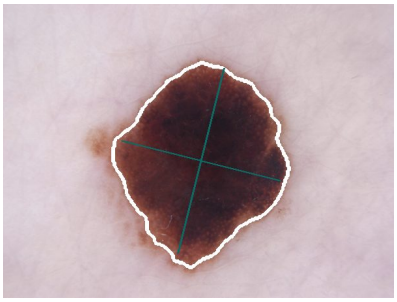
يتجاوز احتمال الورم الميلانيني عتبة الأمان. يوصى بعرض الحالة بسرعة على طبيب الأمراض الجلدية.



الصورة المحللة



المناطق الأكثر تأثيرا (Grad-CAM، «ورم ميلانيني»)



الحدود والمحاور المستخدمة في معايير ABCD

الاحتمالات المقدرة

التشخيص	الاحتمال	ضمن المجموعة المضمونة*
وحمة ميلانينية	55,2%	نعم
ورم ميلانيني	44,8%	نعم
تقرن حميد	0,0%	
آفة وعائية	0,0%	
ورم ليفي جلدي	0,0%	
سرطانة الخلايا القاعدية	0,0%	
تقرن سفعي / داء بوين	0,0%	

* المجموعة المطابقة (طريقة موندريان، ألفا = 0,10): تحتوي على التشخيص الصحيح باحتمال لا يقل عن 90% لكل فئة، بافتراض أن الحالات تشبه بيانات المعايرة. يتخذ قرار الورم الميلانيني إذا كان p(mel) ≥ 0,03 (نسبة التكلفة R = 10).
عتبات النموذج الأصلية، معايرة على مجموعة المعايرة الخاصة به.

معايير ABCD الآلية (استرشادية)

المعيار	القياس	التفاصيل
A — عدم التناظر	2/2	محاور رئيسية غير متناظرة (الشكل أو الألوان)
B — الحواف	0/8	قطاعات ذات حافة حادة
C — الألوان	3/6	بني فاتح، بني داكن، أسود
D — القطر	8,0 مم	أكثر من 6 مم

قياسات آلية استرشادية: على مجموعة الاختبار من HAM10000 لا يميز كل منها بين الورم الميلانيني والوحمة إلا بشكل محدود (AUC من 0,66 إلى 0,73). وهي لا تغني عن الفحص بالمنظار الجلدي.

المراجعة الطبية

أكدها Dr Karim Haddad بتاريخ 19/04/2026.
التشخيص المعتمد: ورم ميلانيني

توقيع الطبيب: _____

تنبيه. أعدت هذه الوثيقة بواسطة أداة للمساعدة على اتخاذ القرار، وهي لا تعد تشخيصا ولا تغني عن الفحص السريري ولا عن الفحص النسيجي. حالة النموذج: بحث — استخدام غير تجاري — ليس جهازا طبيا. بيانات التدريب: BCN20000 + HAM10000 (Tschandl et al., Sci Data 2018, doi:10.1038/sdata.2018.161) (Hernández-Pérez et al., Sci Data 2024, doi:10.1038/s41597-024-03387-w) — الترخيص CC BY-NC 4.0 (غير تجاري).